BỆNH VIỆN ĐA KHOA NHẬT TÂN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

Quy trình kỹ thuật nhận định người bệnh tại khoa Cấp cứu

Bản hoàn thiện để trình thẩm định năm 2026

Quy trình hướng dẫn tiếp nhận, đánh giá ban đầu, xác định mức ưu tiên, bàn giao và theo dõi người bệnh đang chờ tại khoa Cấp cứu. Hoàn thiện từ file nguồn QTKT NHẬN ĐỊNH NGƯỜI BỆNH TẠI KHOA CẤP CỨU.docx, giữ đề cương QĐ 3023/QĐ-BYT. Chưa phải văn bản đã ban hành; bệnh viện xác nhận hệ thống phân loại, nhân sự, thời gian đáp ứng và lịch tái đánh giá trước áp dụng.

Thông tin quản lý	Nội dung
Mã quy trình	Bệnh viện cấp khi ban hành
Phiên bản và ngày rà soát	Dự thảo 1.1 — 13/10/2026
Người biên soạn	……
Người thẩm định và phê duyệt	……
Số quyết định và ngày hiệu lực	……

1. ĐẠI CƯƠNG

Nhận định ban đầu là đánh giá nhanh tình trạng người bệnh để phát hiện nguy cơ và nhu cầu chăm sóc, điều trị. Phân loại cấp cứu là xác định thứ tự ưu tiên; không thay thế chẩn đoán, khám bác sĩ hoặc nhận định đầy đủ sau ổn định.

Mục đích: người bệnh nguy kịch được hỗ trợ ngay, người có nguy cơ cao được ưu tiên, những người đang chờ được theo dõi và tái đánh giá. Thứ tự phục vụ theo mức độ cấp cứu; không chỉ theo thời điểm đến.

Bản nguồn nêu ESI nên bản này dùng mức số ESI 1–5 để trình thẩm định. ESI cần đào tạo và sử dụng đúng tài liệu ENA. ESI không quy định sẵn mốc 10–15 hoặc 30–60 phút đến bác sĩ; màu chỉ là ký hiệu nội bộ nếu được bệnh viện duyệt [3,4]. Không ghép màu và thời gian từ thang khác thành tiêu chí ESI.

2. CHỈ ĐỊNH

Tất cả người bệnh đến khoa Cấp cứu, kể cả tự đến, được vận chuyển, chuyển viện hoặc chưa xác định danh tính. Áp dụng nhận định lại khi tình trạng thay đổi, sau can thiệp, trong thời gian chờ hoặc trước chuyển vị trí chăm sóc.

3. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định tuyệt đối đối với nhận định và phân loại. Người cần can thiệp cứu sống phải được xử trí ngay tại nơi an toàn hoặc chuyển có hỗ trợ vào hồi sức; không chờ hoàn tất phân loại, giấy tờ hoặc đo đủ sinh hiệu.

4. THẬN TRỌNG

Không bỏ sót tình trạng nguy hiểm chỉ vì người bệnh còn đi lại, nói chuyện hoặc sinh hiệu ban đầu chưa bất thường. Đánh giá nguy cơ theo triệu chứng và diễn biến.

Trẻ sơ sinh, trẻ em, người cao tuổi, thai phụ và sau sinh, người suy giảm miễn dịch, người dùng thuốc chống đông, người khó giao tiếp cần nhận định phù hợp tuổi và bệnh cảnh. Không dùng ngưỡng sinh hiệu người lớn cho trẻ em.

Đau ngực, dấu đột quỵ, khó thở, phản vệ, chảy máu nhiều, co giật, rối loạn ý thức hoặc nghi nhiễm trùng nặng cần báo bác sĩ và kích hoạt quy trình chuyên biệt khi phù hợp, không chờ đến lượt thông thường.

Phòng hộ theo nguy cơ lây nhiễm; nhận diện nguy cơ bạo lực, tự hại, nhiễm độc hoặc ô nhiễm hóa chất, huy động hỗ trợ phù hợp. Không để cách ly hoặc yêu cầu hành chính làm chậm xử trí nguy kịch.

Người chưa rõ danh tính được cấp mã tạm theo quy định; kiểm tra lại khi bổ sung thông tin. Đảm bảo riêng tư khi hỏi bệnh, bộc lộ và bàn giao.

5. CHUẨN BỊ

5.1. Người thực hiện

Điều dưỡng được đào tạo nhận định và phân loại; bác sĩ cấp cứu hỗ trợ quyết định và xử trí. Bố trí nhân sự phân loại, theo dõi khu chờ và người nhận bàn giao theo ca. Hộ lý, bảo vệ hỗ trợ vận chuyển và trật tự, không tự quyết định mức ưu tiên chuyên môn.

5.2. Thuốc

Không dùng thuốc thường quy chỉ để phân loại. Thuốc cấp cứu sẵn sàng theo danh mục bệnh viện; sử dụng khi có chỉ định, phác đồ được phê duyệt và trong phạm vi thực hiện.

5.3. Vật tư

Găng, khẩu trang và phòng hộ theo nguy cơ; điện cực, cảm biến phù hợp tuổi; vật tư kiểm tra đường huyết khi chỉ định; phiếu, nhãn hoặc vòng định danh. Nhãn mức ưu tiên ghi số rõ; màu chỉ dùng theo quy ước nội bộ đã duyệt.

5.4. Trang thiết bị

Máy đo huyết áp với băng đúng cỡ, máy SpO2, nhiệt kế, đồng hồ, ống nghe; phương tiện đánh giá đường huyết khi cần. Xe đẩy, cáng, monitor, oxy, hút, bóng và máy sốc/AED tiếp cận được theo bố trí cấp cứu; kiểm tra hoạt động trước ca.

5.5. Người bệnh

Tiếp đón tại khu phân loại hoặc đánh giá ngay trên cáng khi cần. Giải thích ngắn, đặt tư thế theo tình trạng, bảo đảm riêng tư và có hỗ trợ khi nguy cơ ngã; không di chuyển người nguy kịch thiếu hỗ trợ.

5.6. Hồ sơ bệnh án

Phiếu nhận định và phân loại hoặc hồ sơ điện tử; hồ sơ chuyển viện nếu có. Có trường giờ đến, giờ phân loại, triệu chứng, sinh hiệu, mức ưu tiên và căn cứ, can thiệp, giờ bàn giao, người nhận và lần tái đánh giá.

5.7. Thời gian thực hiện kỹ thuật

Đánh giá đe dọa tính mạng ngay khi tiếp xúc. Người ổn định có thể hoàn thành phân loại ban đầu khoảng 2–5 phút theo dự kiến của bản nguồn; đây không phải thời gian được phép trì hoãn cứu sống. Thời gian đáp ứng và tái đánh giá theo mức nguy cơ cần bệnh viện quy định.

5.8. Địa điểm thực hiện kỹ thuật

Khu vực phân loại tại lối vào khoa Cấp cứu, khu hồi sức hoặc vị trí người bệnh đang ở khi không thể di chuyển an toàn. Khu chờ phải có người phụ trách, quan sát và phương tiện gọi hỗ trợ.

5.9. Kiểm tra hồ sơ và người bệnh

Đối chiếu ít nhất hai thông tin định danh nếu có; cấp mã tạm nếu chưa rõ. Ghi giờ đến, kiểm tra hồ sơ chuyển viện, triệu chứng và nguy cơ; đánh giá an toàn tư thế. Không trì hoãn nhận định hoặc cấp cứu vì thiếu hồ sơ.

6. TIẾN HÀNH QUY TRÌNH KỸ THUẬT

6.1. Bước 1 Tiếp cận và quan sát ngay

Quan sát ý thức, khả năng nói, thở, màu da, tư thế, chảy máu và dấu nguy hiểm từ lúc tiếp cận. Bảo đảm an toàn, mang phòng hộ phù hợp. Nếu có nguy cơ đe dọa tính mạng, gọi bác sĩ và đội cấp cứu ngay, đồng thời can thiệp trong phạm vi được phân công.

6.2. Bước 2 Nhận diện ngừng tuần hoàn hoặc nguy cơ tức thì

Nếu không đáp ứng và không thở bình thường, đánh giá theo quy trình ngừng tuần hoàn của bệnh viện; không kéo dài kiểm tra hoặc tiếp tục hỏi bệnh. Kích hoạt cấp cứu, bắt đầu hồi sinh tim phổi và sử dụng AED hoặc máy sốc theo đào tạo; tổ chức chuyển có hỗ trợ. Chảy máu ngoài ồ ạt cần cầm máu khẩn song song.

6.3. Bước 3 Nhận định A đường thở

Đánh giá khả năng nói, âm thanh bất thường, dịch hoặc dị vật nhìn thấy và dấu tắc. Gọi hỗ trợ, thực hiện mở đường thở hoặc hút khi có chỉ định theo quy trình tương ứng; nghi chấn thương cần bảo vệ cột sống cổ. Không móc tìm dị vật mù. Đánh giá lại sau can thiệp.

6.4. Bước 4 Nhận định B hô hấp

Quan sát nhịp, gắng sức và độ cân xứng lồng ngực; đo SpO2 khi có thể, đánh giá chất lượng tín hiệu. Suy hô hấp cần hỗ trợ oxy hoặc thông khí theo tình trạng và quy trình; gọi bác sĩ ngay. Không chờ kết quả SpO2 khi biểu hiện suy hô hấp rõ.

6.5. Bước 5 Nhận định C tuần hoàn

Đánh giá mạch, huyết áp khi có thể, tưới máu ngoại vi và chảy máu. Cầm máu trực tiếp khi thích hợp, hỗ trợ monitor và đường truyền theo chỉ định; báo dấu sốc. Không cho một phác đồ bù dịch chung cho mọi bệnh cảnh.

6.6. Bước 6 Nhận định D thần kinh

Đánh giá AVPU hoặc Glasgow phù hợp, thay đổi ý thức và dấu thần kinh khu trú; đo đường huyết khi nghi rối loạn đường huyết hoặc rối loạn ý thức theo quy trình. Co giật hoặc nghi đột quỵ cần báo và kích hoạt quy trình tương ứng, ghi thời điểm khởi phát hoặc cuối còn bình thường nếu biết.

6.7. Bước 7 Nhận định E bộc lộ có mục tiêu

Bộc lộ vùng cần khám để tìm tổn thương, phát ban hoặc chảy máu; giữ riêng tư và giữ ấm. Đo nhiệt độ và tìm dấu liên quan khi phù hợp. Đánh giá lại từ A khi có thay đổi; xử trí nguy cơ phát hiện trước khi tiếp tục [5].

6.8. Bước 8 Hỏi bệnh ngắn và bổ sung sinh hiệu

Sau khi loại trừ hoặc đang xử trí nguy cơ tức thì, hỏi lý do đến, khởi phát, diễn biến, dị ứng, thuốc đang dùng và bệnh nền; lấy thông tin từ người đi cùng hoặc nhân viên vận chuyển nếu cần. Ghi đau, mạch, huyết áp, nhịp thở, SpO2, nhiệt độ và ý thức; ghi rõ chỉ số chưa đo được, không bỏ qua nguy cơ vì thiếu dữ liệu.

6.9. Bước 9 Xác định và ghi mức ưu tiên

Dùng hệ thống phân loại đã được bệnh viện lựa chọn và nhân viên được đào tạo. Nếu dùng ESI, đối chiếu bảng diễn giải bên dưới và tài liệu chính thức; mức 1 hoặc 2 được xem xét trước khi dự đoán nguồn lực. Sinh hiệu bất thường hoặc nghi nguy cơ cao cần đánh giá lại và báo bác sĩ; không tự xếp thấp để giảm quá tải.

6.10. Bước 10 Điều phối và bàn giao

Chuyển đến vị trí điều trị phù hợp mức ưu tiên, có người và phương tiện hỗ trợ theo nguy cơ. Bàn giao ISBAR: định danh, lý do và diễn biến, nhận định, mức ưu tiên và căn cứ, can thiệp và đáp ứng, việc cần làm. Xác nhận người nhận và giờ nhận; trường hợp nguy kịch vẫn duy trì chăm sóc cho đến khi tiếp nhận.

6.11. Bước 11 Hướng dẫn và quản lý người chờ

Chỉ bố trí chờ khi đủ an toàn; thông báo đây là mức đánh giá hiện tại, có thể thay đổi. Hướng dẫn báo ngay khi khó thở, đau tăng, chóng mặt, ngất, chảy máu hoặc triệu chứng mới. Phân công người quan sát, ghi kế hoạch tái đánh giá; không để người có nguy cơ cao chờ không giám sát.

6.12. Bước 12 Tái đánh giá và hoàn tất hồ sơ

Tái đánh giá ngay khi có thay đổi, sau can thiệp và theo lịch đã duyệt. Ghi sinh hiệu, ý thức, triệu chứng và mức ưu tiên mới nếu đổi, thời điểm và lý do; báo bác sĩ và cập nhật nhãn, khu vực, người nhận. Ghi đầy đủ cả giờ đến, giờ phân loại và bàn giao, không chỉ ghi giờ nhập hồ sơ.

Diễn giải mức ESI để đối chiếu

Bảng tóm tắt không thay thế thuật toán và đào tạo ESI chính thức [4]. Không đếm từng xét nghiệm riêng thành từng nguồn lực; cách đếm và điều chỉnh theo tuổi thực hiện đúng tài liệu đào tạo.

Mức	Căn cứ khái quát
1	Cần can thiệp cứu sống ngay.
2	Nguy cơ cao, thay đổi ý thức mới, đau hoặc distress nặng theo đánh giá.
3	Sau loại trừ mức 1–2: dự kiến từ hai loại nguồn lực trở lên; kiểm tra sinh hiệu để cân nhắc nâng mức.
4	Sau loại trừ mức 1–2: dự kiến một loại nguồn lực.
5	Sau loại trừ mức 1–2: không dự kiến nguồn lực theo định nghĩa ESI.

Màu, thời gian đến bác sĩ và khoảng tái đánh giá do bệnh viện xác định trong quy định triển khai; không lấy bảng màu và mốc phút của bản nguồn làm tiêu chuẩn ESI. Người cần hồi sức được can thiệp ngay, không chờ một mốc thời gian.

7. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ TAI BIẾN

7.1. Theo dõi và tái đánh giá

Theo dõi tình trạng hiện tại và nguy cơ thay đổi, mức đau, ý thức, hô hấp, tuần hoàn, nhu cầu hỗ trợ và thời gian chờ. Đo lại theo chỉ định và kế hoạch của bệnh viện; người có nguy cơ cao cần mức giám sát phù hợp. Không dùng chung khoảng 15–30 phút cho mọi người bệnh hoặc xem đó là thời gian có thể chờ khi xấu đi.

7.2. Diễn biến nguy kịch tại khu phân loại hoặc khu chờ

Gọi hỗ trợ ngay, nhận định lại và xử trí theo quy trình cấp cứu phù hợp; ngừng tuần hoàn chuyển ngay sang hồi sinh tim phổi. Phân công người gọi, người can thiệp và người chuẩn bị phương tiện; không bỏ người bệnh khi đi tìm dụng cụ. Sau ổn định, cập nhật mức, khu chăm sóc và bàn giao.

7.3. Phân loại thấp hơn nguy cơ hoặc chậm tiếp nhận

Đánh giá lại ngay, nâng ưu tiên khi cần, báo bác sĩ phụ trách và điều phối tới vị trí an toàn; ghi lý do thay đổi. Khi quá tải, kích hoạt phương án điều phối nội bộ, không hạ mức để phù hợp số giường. Báo cáo sự cố hoặc tình huống suýt gây sự cố theo quy định; rà soát nguyên nhân và cải tiến.

7.4. Sai định danh hoặc thiếu bàn giao

Xác minh đúng người bệnh, giữ mã tạm và các dữ liệu có liên quan để tránh trộn hồ sơ; phối hợp sửa theo quy định. Nếu chưa có người nhận, người bàn giao phải bảo đảm giám sát và báo người phụ trách để giải quyết; ghi rõ thời điểm và hành động.

Tài liệu tham khảo

[1] QĐ 3023/QĐ-BYT ngày 28/7/2023 về đề cương tài liệu chuyên môn hướng dẫn quy trình kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh.

https://bvdkbaclieu.gov.vn/van-ban-phap-quy/quyet-dinh-so-3023-qd-byt-cua-bo-y-te-ve-viec-ban-hanh-de-cu.html

[2] Thông tư 31/2021/TT-BYT ngày 28/12/2021 quy định hoạt động điều dưỡng trong bệnh viện.

https://vbpl.vn/TW/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=152956

[3] Emergency Nurses Association Triage Portfolio, hướng dẫn nguồn đào tạo ESI.

https://www.ena.org/education/emergency-nursing-triage-education-program/triage-portfolio

[4] Emergency Nurses Association Emergency Severity Index Handbook Fifth Edition.

https://d1w2w5dpazlk1u.cloudfront.net/ENA/pdf/729e51c2-2e61-4a39-ba83-441d729c71d1.pdf

[5] Resuscitation Council UK The ABCDE Approach.

https://www.resus.org.uk/library/abcde-approach

[6] Resuscitation Council UK Adult Basic Life Support Guidelines 2025; đối chiếu nhận diện ngừng tuần hoàn, triển khai theo quy trình hồi sinh bệnh viện.

https://www.resus.org.uk/professional-library/2025-resuscitation-guidelines/adult-basic-life-support-guidelines

Nguồn đối chiếu ngày 13/10/2026. Dẫn chiếu “Tài liệu đào tạo Cấp cứu cơ bản, Bộ Y tế” của bản nguồn chưa có số quyết định, phiên bản hoặc bản gốc nên chưa sử dụng làm căn cứ xác minh độc lập. Bệnh viện bổ sung phác đồ và tài liệu đào tạo được phê duyệt đang sử dụng.

Phụ lục 1 Danh mục chuẩn bị

Số lượng dưới đây là đề xuất tối thiểu theo một vị trí phân loại; nhân lực theo ca, vật tư theo số người bệnh và nguy cơ. Bệnh viện xác nhận khi triển khai.

TT	Danh mục	Đơn vị	Dự kiến	Ghi chú
1	Điều dưỡng phân loại đã được đào tạo	Người	01	Theo vị trí và ca
2	Bác sĩ cấp cứu hỗ trợ	Người	Theo ca	Có cơ chế gọi ngay
3	Hộ lý và bảo vệ hỗ trợ	Người	Theo ca	Không tự quyết định mức
4	Găng, khẩu trang, phòng hộ	Bộ	Theo nhu cầu	Theo nguy cơ
5	Phiếu, nhãn, vòng định danh	Bộ	01/NB	Mức số rõ; màu nội bộ
6	Huyết áp và băng đúng cỡ	Bộ	01	Phụ kiện trẻ em khi cần
7	SpO2 và cảm biến phù hợp	Bộ	01	Kiểm tra tín hiệu
8	Nhiệt kế, đồng hồ, ống nghe	Bộ	01	Kiểm tra trước ca
9	Đường huyết và vật tư	Bộ	Sẵn có	Dùng khi có chỉ định
10	Cáng, xe đẩy, phương tiện cấp cứu	Bộ	Sẵn có	Oxy, hút, bóng, AED/máy sốc, monitor tiếp cận được

Phụ lục 2 Phiếu nhận định và tái đánh giá

Ngày …… Khoa Cấp cứu; họ tên …… Mã NB hoặc mã tạm ……

Ngày sinh hoặc tuổi …… Thông tin định danh thứ hai ……

Giờ đến …… Giờ bắt đầu nhận định …… Người thực hiện ……

Lý do đến và khởi phát hoặc cuối còn bình thường ……

Dị ứng, thuốc, bệnh nền và thông tin chuyển viện ……

A …… B …… C …… D …… E ……

Mạch …… Huyết áp …… Nhịp thở …… SpO2 …… Oxy nếu có …… Nhiệt độ …… Ý thức …… Đau ……

Mức ưu tiên …… Hệ phân loại và phiên bản …… Căn cứ …… Chỉ số chưa đo được và lý do ……

Can thiệp và đáp ứng ……

Khu tiếp nhận …… Giờ bàn giao …… Người giao …… Người nhận …… Việc cần làm ……

Kế hoạch theo dõi và lần tái đánh giá tiếp theo theo tình trạng/quy định ……

Giờ	Diễn biến và sinh hiệu	Mức và lý do đổi	Xử trí/báo/bàn giao	Người đánh giá
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……
……	……	……	……	……

Xác nhận trước ban hành: hệ thống phân loại và bản đào tạo ……; quy ước màu nếu dùng ……; thời gian đáp ứng và lịch tái đánh giá theo mức nguy cơ ……; người phụ trách khu chờ và hỗ trợ khi quá tải ……

Người biên soạn **Người thẩm định** **Người phê duyệt**